

HISTORIA CLÍNICA DE FISIATRÍA

REALIZA ATENCIÓN DEL PACIENTE POR CONSULTA, PREVIAMENTE CONFIRMADA POR VÍA TELEFÓNICA, CON ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO DE NEUMATOLOGÍA RESPIRATORIA Y FIRMA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO CORRESPONDIENTE, POR PARTE DEL PACIENTE ANTERIOR A LA CONSULTA. ATIENDE PACIENTE PREVIA DESINFECCIÓN DEL ÁREA DEL CONSULTORIO, CON TODAS LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD; LAVADO DE MANOS PREVIO, USO DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PREVIO A LA CONSULTA, USO DE TAPABOCAS N95, USO DE VISOR PANORÁMICO, USO DE BATA ANTIFLUIDOS, USO DE GUANTES DESECHABLES PARA SU EXÁMEN FÍSICO

FECHA: 2025-01-31 09:25:49

NOMBRE: SANTIAGO ROJAS RODRIGUEZ
DIRECCION: ERA ETAPA MZ 1 CA 5
BARRIOS: LOS QUINDOS
EPS: EPS SURA

EDAD: 22 SEXO: M HC: 1004683619
TELEFONO: 3207444882

MOTIVO DE CONSULTA: MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (FISIATRÍA)
CONTROL - PREVIAMENTE DRES. VÁSQUEZ Y ARIAS

Paciente de 22 años con Dx:

Parálisis cerebral tipo hemiparesia espástica

Déficit cognoscitivo secundario

Asimetría de MMII

Antecedente de corrección de coxa valga izquierda - MAOS en fémur y en acetábulo (2017)

Asiste con Soledad Rodríguez (madre).

ANTECEDENTES:

** Neuropsicología 16/08/2023 Motricidad fina y gruesa: Dificultad para amarrarse los zapatos, cierta dificultad motriz gruesa por antecedente médico. Cierta dificultad en la mecánica de la escritura Independencia en Actividades Instrumentales (AIVD): Muestra la capacidad de transportarse solo y trasladarse, manejo del dinero. Atención y concentración: Sin dificultades atencionales Lenguaje: Adecuada comprensión y expresión verbal Memoria: Sin dificultades aparentes Percepción: Uso de gafas permanentes, adecuada audición Comportamiento y estado de ánimo: Baja tolerancia a la frustración, irritabilidad.

>> Dr Arias 01/06/2023 lesión cerebral neonatal, hemiparesia izq. pobre prehensión palmar izq., acortamiento de MII aprox. 5 cm, manejo con bota ortopédica de 10 cm, solicito Rx panorámica de MI, ortesis braquiopalmar izq. para uso nocturno y ortesis dinámica muñeca y dedos zq. con resortes para ext. de dedo medio y anular,

** Rx panorámica de MI MID de 82.5 cm izq. de 80.1 cm diferencia de 24 mm, genu varo bilateral.

RGE, hipercalcemia

Cx corrección de coxa izq. con MAOS en fémur y acetábulo 2017, varias en MSI, apendicectomía

También recibió toxina botulínica en antebrazo izq. (3 aplicaciones)

ENFERMEDAD ACTUAL: Actualmente refiere:

- Aumento del tono muscular.
- No tiene manejo mio-relajante.
- Continúa uso de ortesis para miembro superior, con adecuada tolerancia. La usa únicamente en la noche.
- Paresia de reciente aparición en miembro inferior - "se le queda bloqueada". 4 episodios en los 2 últimos 2 meses.
- Sensación de crêpitos en cadera.
- Aporta Rx panorámica columna (22 junio 2023 - Radiólogos): Acortamiento de MI izquierdo de 24 mm, genu varo bilateral, presencia de material quirúrgico en alerón iliaco izquierdo, cuello femoral y en región transtrocanterica, disminución de altura en el espacio femoro acetabular izquierdo.

HISTORIA CLÍNICA DE FISIATRIA

Adecuado uso y tolerancia a la ortesis de miembro inferior.

EXPLORACIÓN FÍSICA: Buen estado general.

Ingresa caminando por sus medios.

Acepta el examen físico.

Marcha hemiparética izquierda.

Ashworth 2 en flexores del codo, del carpo y de los dedos, en aductores de cadera, flexores de rodilla y plantiflexores.

Codo con actitud en flexión que pasivamente llega a -10 grados.

Muñeca en actitud de extensión de 45 grados, pasivamente llega a neutro.

Hiperreflexia ++++ rotulian y aquilian, con clonus agotable en este último nivel.

Flexión MCF e IF de dedos 2 a 5.

Ortesis tobillo pie en polipropileno, articulada y con tope a la plantiflexión.

Marcha con inclinaciones laterales del tronco, ausencia de paso escapular, pie caído dinámico y sobreposición de segundo artejo sobre el primero.

PLAN DE MANEJO: Paciente con parálisis cerebral tipo hemiparesia espástica izquierda.

Se beneficia de uso de biorrelajante y de ortesis más liviana dado que la alteración es dinámica.

Se ordena:

- Baclofeno 10 mg cada 8 horas.

- Ortesis tobillo pie en fibra de carbono, con pilón posterior recto, sujeción por velcros proximales y materail de la suela que se pueda cortar para ajuste al calzado. Adicionar realce en material semirrígido de 2.5 mm en retropié que disminuya hasta 0 mm en mediopié.

Cita control.

DIAGNOSTICO PPAL: G811-HEMIPLEJIA ESPASTICA

DIAGNOSTICO RELACIONADO 1: G800-PARALISIS CEREBRAL ESPASTICA CUADRIPEJICA

DIAGNOSTICO RELACIONADO 2:

DIAGNOSTICO RELACIONADO 3:



Pida su cita a través del portal
www.agendamedicacolombiana.com

CAMILO HERNANDO CHAVES ANGARITA

REG MEDICO:

ESPECIALIDAD: FISIATRIA

Carrera 10 # 14 norte 59 Barrio La Campiña

Telefono Fijo: 7362260

Telefono Celular: 3217126990 - 3022242435

Whatsapp: 3217126990

Correo Electronico: auxadministrativo1@clinicaneuromental.com - servicioalcliente@clinicaneuromental.com - citas@clinicaneuromental.com - gerencia@clinicaneuromental.com

Unete al grupo de padres en Facebook o Instagram: Neuromental - Pagina web: www.clinicaneuromental.com